객혈에서 트라넥삼산: 가교 치료의 근거와 처방 전 확인

트라넥삼산(tranexamic acid)은 급성 객혈에서 확정적 중재 전 가교 요법으로 고려한다.

핵심 판단 한눈에

기도·혈역학 안정화
출혈측 아래 · 기도 보호

→

가교 요법 검토
Tranexamic acid

→

원인·위치 평가 및 중재
CT·BFS·BAE 가능 병원

기도·혈역학 안정화와 원인·위치 평가를 우선하고, 트라넥삼산은 중재 전 가교 역할로 고려한다.

강의의 근거 설명

항섬유소용해 작용 · 투여 목적

Plasminogen 활성화를 경쟁적으로 억제한다. 연자는 주로 중등도 이상 객혈 연구에서 객혈 중증도 및 초기 처치 후 추가 처치 필요성을 줄이는 효과를 소개했다.

연자 병원 사용 예 · 0:33:19 발언

상황·경로	용량·빈도·기간
활동성 출혈 · 정맥	처음 1,000mg 부하, 이후 500mg을 6시간 간격으로 하루 4회. 주사제 500mg/5mL, normal saline 50mL 혼합 예시
대량이 아닌 경우 · 경구	500mg 하루 3회, 약 1주 또는 출혈이 멎을 때까지
투여기간	너무 길게 사용하면 혈전증 관련 합병증을 고려하여 결정

처방 전·전원 전 확인

- ☐ 단순 출혈량 외 **출혈 속도·환자 상태**로 중증도를 판단한다.
- ☐ 병력·약물력·진찰, CBC·신기능·간기능·응고검사를 확인한다.
- ☐ 대량 객혈: 기도·혈역학 안정화, 출혈측 아래 자세(lateralization), 필요 시 기도 보호 후 CT·기관지내시경·기관지동맥색전술 가능한 병원으로 전원한다.
- ☐ 비중증: 원인 치료 후 **24–48시간 내 재평가**. 지속되거나 원인 규명이 어려우면 전원한다.